

AFMCP Chap6 소통·호르몬 균형 Part 1 — 핵심 요약

1. 핵심 개념

- 부신 조절 이상은 만성 복합 질환 환자에서 거의 보편적으로 존재
- 부신의 존재 이유: '스트레스 환경에서 최대 수행을 위한 지원'
- 급성 스트레스 = 목적 있는 과정 / 만성 스트레스 = 조절 이상 → 만성 질환
- 코르티솔은 에너지 동원·면역 억제·인지 기능에 핵심 역할

2. 부신 조절 이상 스펙트럼

쿠싱병 → 아증후성 고코르티솔혈증(흔함) → 아증후성 저코르티솔혈증(흔함) → 에디슨병

- DHEA 감소 = 중장기 스트레스의 임상 지표
- 비유: 부신 = 체장 (인슐린 저항성처럼 '코르티솔 저항성' 발생 가능)

3. 알로스타시스와 알로스타틱 부하

- Eustress(유익한 스트레스) vs Distress(해로운 스트레스)
- 알로스타틱 부하 = 신체의 마모와 손상
- 사회적 건강 결정요인 = 웨더링(weathering) → 암 위험 4배 증가 연구
- 멀티태스킹도 강력한 만성 스트레스

4. STAINS 기억법 (ATM 파악 도구)

S(스트레스/수면/좌식/사회결정요인) - T(독소) - A(알레르겐) - I(감염/염증/장/영양) - N(영양) - S

5. 임상 소견 핵심

- 불안·피로·브레인 포그·중심성 비만·불면 → 코르티솔 과잉 의심
- 인지 저하·정신건강 문제 → 코르티솔 결핍(후기 단계) 의심
- 위협 인식(perception)이 실제 위협만큼 강력한 부신 자극 요소